Azienda Ospedaliera Riunita Partenope Est
Presidio Ospedaliero Santa Lucia ai Ponti Rossi
Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Parassitologia
in collaborazione con UOSD Ematologia di Laboratorio
Direttore UOC: Dott. Gennaro Capasso

Via Nuova Poggioreale 61
80143 Napoli
Tel. 081 7702144
Fax 081 7702190
parassitologia@aorpe.example.it

REFERTO DI LABORATORIO - URGENTE

Screening sanitario del migrante e diagnostica parassitologica

ASSISTITO (STP)

Cognome e nome:	**NDIAYE Ousmane**
Codice STP:	**STP1502010004512**
Nato il:	**10/02/1998**
Luogo di nascita:	**Dakar (Senegal)**
Cittadinanza:	**senegalese**
Domicilio:	**c/o Centro di Accoglienza Il Faro, Via Taddeo da Sessa 12, Napoli**
Recapito:	**+39 389 117 6042**
Lingua:	**wolof, francese**

Richiesta n.:	MP-26-031877
Provenienza:	Ambulatorio Medicina delle Migrazioni
Medico richiedente:	Dott.ssa Raffaella Iovino
Prelievo:	21/09/2026 ore 09:40
Accettazione campione:	21.09.26 ore 10:02
Ultima validazione:	24 settembre 2026

Campione EDTA: MP26031877E1

Notizie cliniche. Giovane uomo di 28 anni, in Italia da circa 3 mesi (sbarcato a Lampedusa dopo un lungo transito in Libia), giunto in PS per febbre intermittente con brivido e cefalea da 5 giorni. Accompagnato dal cugino, sig. Cheikh Ndiaye, domiciliato presso lo stesso centro. Colloquio condotto con la mediatrice culturale sig.ra Aminata Sow. Il pz. riferisce di essere di religione musulmana e di non osservare al momento restrizioni alimentari. Nessuna profilassi antimalarica assunta.

PARASSITOLOGIA - RICERCA PLASMODI (URGENTE)

Esame	Risultato	U.M.	Note
Test antigenico rapido (HRP2 / pLDH)	Positivo HRP2 e pan-pLDH		Eseguito alle 10:25, comunicato in PS
Goccia spessa (colorazione di Giemsa)	Positiva		Trofozoiti ad anello, rari gametociti
Striscio sottile - specie	Plasmodium falciparum		Identificazione morfologica, conferma in PCR (1)
Parassitemia	1,8	%	Soglia di malaria grave: > 2% (non superata)
PCR Plasmodium spp. (real time)	P. falciparum DNA rilevato		Assenza di co-infezione con altre specie

Monitoraggio della parassitemia in corso di terapia con artemether-lumefantrina 80/480 mg (aggiornato all'ultima validazione)

Controllo	Data e ora prelievo	Parassitemia (%)	Gametociti	Operatore
T0 (ingresso)	21/09/2026 09:40	1,8	rari	inf. P. Ruocco
T + 24 h	22/09/2026 09:30	0,6	rari	inf. Anna Iaccarino
T + 48 h	23-09-2026 09:50	0,05	assenti	inf. Anna Iaccarino
T + 72 h	24.09.26 08:45	non rilevabile	assenti	inf. P. Ruocco

Terapia impostata dal Dott. Ciro Amitrano con artemether-lumefantrina 80/480 mg 6 dosi in 3 giorni; risposta parassitologica adeguata (riduzione superiore al 75% a 48 ore).

EMATOLOGIA ED EMOGLOBINOPATIE

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Emoglobina	10,7	g/dL	13,5 - 17,5	L
MCV	78,4	fL	80,0 - 99,0	L
Piastrine	87	10^3/µL	150 - 450	L
Leucociti	5,12	10^3/µL	4,00 - 10,00	
Eosinofili (assoluti)	0,94	10^3/µL	0,02 - 0,50	H
Bilirubina indiretta	1,62	mg/dL	< 0,80	H
LDH	418	U/L	135 - 225	H
Test di Coombs diretto	Negativo			

Elettroforesi capillare dell'emoglobina (HPLC di conferma)

Frazione	Risultato	Riferimento	Interpretazione
HbA	58,9 %	95,0 - 98,0 %	Quadro compatibile con portatore sano di HbS (tratto drepanocitico, genotipo HbAS). Si consiglia consulenza genetica e, se desiderato, test del partner prima di una gravidanza (2).
HbS	37,6 %	assente	-
HbA2	3,1 %	2,0 - 3,3 %	-
HbF	0,4 %	< 1,0 %	-

SIEROLOGIA E SCREENING INFETTIVOLOGICO

Esame	Risultato	Indice / titolo	Interpretazione
HBsAg	Reattivo	> 250 UI/mL	Infezione da HBV in atto; avviati HBeAg, anti-HBe, HBV-DNA, anti-HDV
Anti-HBc IgM	Non reattivo	-	Esclude infezione acuta recente
Anti-HCV	Non reattivo	-	-
HIV 1-2 Ag/Ab	Non reattivo	-	Test eseguito previo consenso informato verbale, alla presenza della mediatrice
Treponema pallidum Ab	Non reattivo	-	-
Schistosoma spp. IgG (ELISA)	Reattivo	2,7 index	Sospetta schistosomiasi: richiesto esame urine su raccolta delle ore 12-14
Strongyloides stercoralis IgG	Debolmente reattivo	1,3 index	In zona grigia; eosinofilia presente, ripetere a 4 settimane
QuantiFERON-TB Plus	Positivo	TB1 1,46 / TB2 1,71 UI/mL	Compatibile con infezione tubercolare latente in assenza di sintomi respiratori; Rx torace programmato

MICROBIOLOGIA

Campione	Esame	Esito
Espettorato (1/3)	Ricerca BAAR (Ziehl-Neelsen)	Assenti bacilli alcool-acido resistenti
Espettorato (1/3)	PCR M. tuberculosis complex	Non rilevato
Feci (3 campioni)	Esame parassitologico (concentrazione)	Uova di Schistosoma mansoni nel campione del 22/09/2026
Sangue (2 set)	Emocoltura	Sterile dopo 5 giorni

Diagnosi di laboratorio: malaria da Plasmodium falciparum non complicata in soggetto con tratto drepanocitico e epatite B cronica da caratterizzare. Valore critico (parassitemia) comunicato alle ore 10:31 del 21/09/2026 dalla Dott.ssa Teresa Vitiello al medico di guardia del PS, Dott. Ciro Amitrano. Il pz. Ndiaye e' stato informato con l'aiuto della mediatrice.

Personale

Prelievo: inf. Pasquale Ruocco. Lettura vetrini: TSLB Rosaria Mautone, revisione Dott. G. Capasso. Elettroforesi Hb: TSLB Luigi Sannino.

A.O. PARTENOPE EST
MICROBIOLOGIA
Dott. Gennaro Capasso
Ord. Medici NA n. 28741

Consegna e contatti

Referto consegnato al sig. O. Ndiaye in data 25/09/2026; copia al cugino C. Ndiaye su delega scritta. Recapito del centro di accoglienza: 081 5530127, educatore di riferimento sig. Fabio Esposito.

Il Dirigente Medico - Ematologia di Laboratorio
Dott.ssa Teresa Vitiello
Validazione sezione parassitologica: Dott. Gennaro Capasso

Napoli, 24/09/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ritiro referto STP STP1502010004512:
https://referti.aorpe.example.it/stp/MP26-RF-008815

(1) Conferma molecolare eseguita su campione MP26031877E2; ceppo conservato per sorveglianza delle resistenze.
(2) Il dato genetico e' comunicato esclusivamente all'interessato; la condivisione con familiari (es. il cugino sig. Cheikh Ndiaye) richiede consenso espresso.
(3) Tecnica di Giemsa a pH 7,2; conta su 2.000 eritrociti.